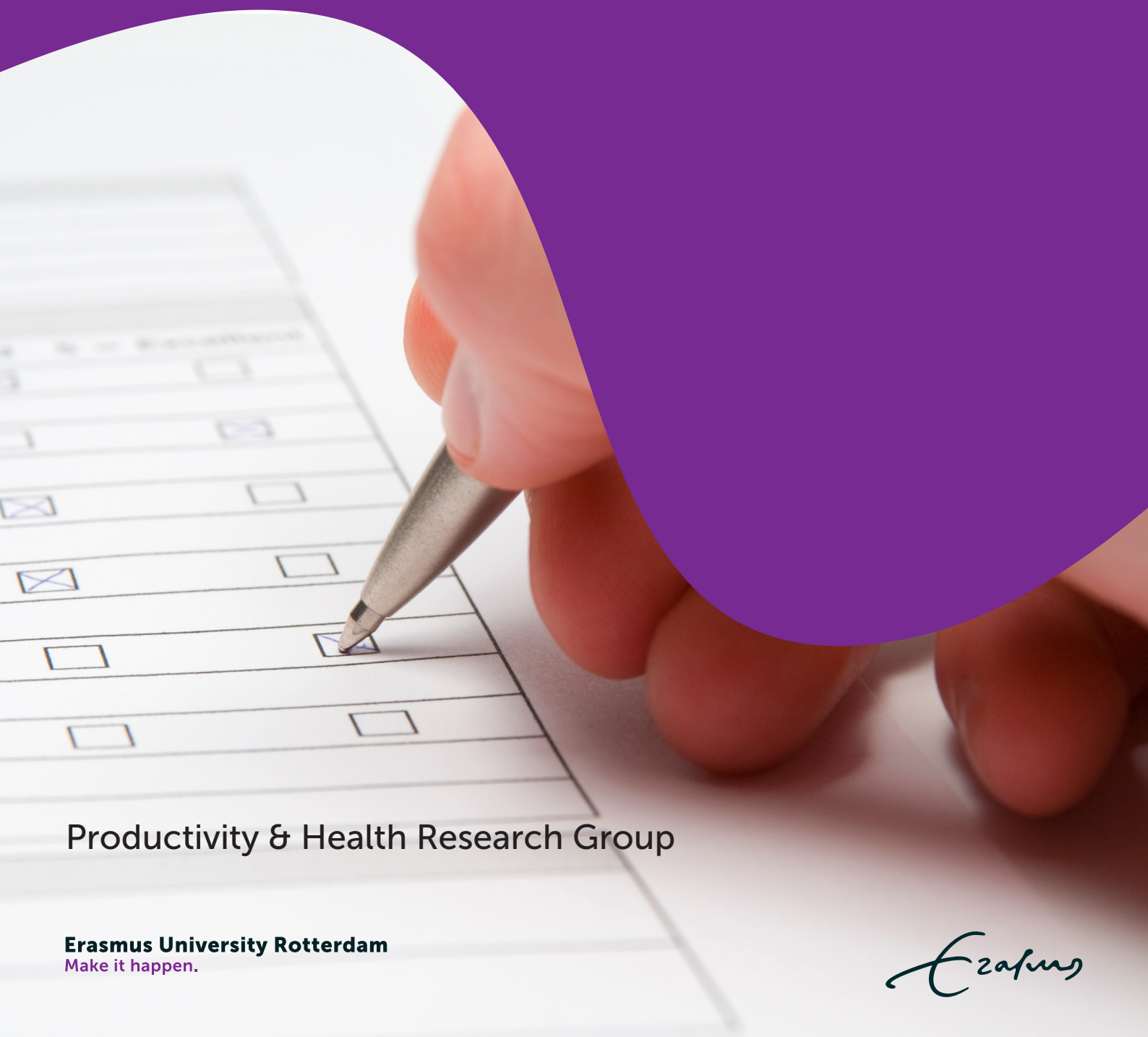


# Productivity Costs Questionnaire Handleiding



Productivity & Health Research Group

## HANDLEIDING

# iMTA Productivity Costs Questionnaire

*Productivity and Health Research Group*

Institute for Medical Technology Assessment  
Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, oktober 2018



De iPCQ is in 2013 ontwikkeld door de *Productivity and Health Research Group*, bestaande uit Drs C Bouwmans, Dr L Hakkaart-van Roijen, Dr M Koopmanschap, Dr M Krol, Prof dr H Severens en Prof dr W Brouwer.

*“Alle auteursrechten zijn en blijven voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt gewijzigd of vermenigvuldigd zonder toestemming van de auteurs. Deze toestemming is verkrijgbaar onder de voorwaarden zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden.”*

## Inhoudsopgave

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding.....                                                | 4  |
| 1.1 Achtergrond.....                                             | 4  |
| 1.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de <i>i</i> PCQ ..... | 6  |
| 1.3 Steekproefgrootte, meetmomenten en recall-periode .....      | 7  |
| 1.4 Opbouw van de handleiding .....                              | 8  |
| 2. Opbouw <i>i</i> PCQ .....                                     | 9  |
| 2.1 Algemene vragen .....                                        | 9  |
| 2.2 Algemene vragen over betaald werk .....                      | 10 |
| 2.3 Modules van productiviteitsliezen .....                      | 10 |
| 3. Scoring en waardering van productiviteitsverliezen .....      | 14 |
| 3.1 Module 1: Absenteïsme. Verzuim van betaald werk .....        | 14 |
| 3.2 Module 2: Presenteeïsme.....                                 | 20 |
| 3.3 Module 3: Productiviteitsverlies van onbetaald werk.....     | 21 |
| 4. Feasibility en validiteit .....                               | 23 |
| 5. Gebruik van de <i>i</i> PCQ .....                             | 24 |
| 5.1 Algemeen.....                                                | 24 |
| 5.2 Gebruikersvoorwaarden .....                                  | 25 |
| 6. Referenties.....                                              | 27 |
| Bijlage I Vragenlijst <i>i</i> PCQ .....                         | 30 |
| Bijlage II Optionele vraag .....                                 | 39 |

# 1. Inleiding

## 1.1 Achtergrond

In economische evaluaties van gezondheidszorg wordt onderzoek gedaan naar de kosten en de baten van medische interventies. Vanuit de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg wordt voorgeschreven dat een economische evaluatie dient uit te gaan van een 'maatschappelijk perspectief' [1]. Het maatschappelijk perspectief houdt rekening met alle actoren in de samenleving; alle kosten moeten worden meegenomen, ongeacht wie de kosten draagt of de baten ontvangt. Bij de waardering van kosten in economische evaluaties wordt uitgegaan van het principe van opportunity costs. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van schaarse, alternatief aanwendbare middelen.

In de Nederlandse richtlijnen worden kosten onderverdeeld in drie categorieën: kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van patiënten en familie en kosten in andere sectoren. In Tabel 1 wordt een aantal voorbeelden gegeven van kosten binnen de drie kostencategorieën. Het hanteren van een maatschappelijk perspectief impliceert dat alle kosten en baten dienen te worden meegenomen in een economische evaluatie. Dit betekent dat alle kosten in Tabel 1, wanneer relevant, dienen te worden geïncludeerd in een economische evaluatie.

Tabel 1. Voorbeelden van kostencategorieën in economische evaluaties.

| <b>Kosten binnen de gezondheidszorg</b> | <b>Kosten van patiënten en familie</b> | <b>Kosten in andere sectoren</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Huisartsconsulten                       | Reiskosten                             | Productiviteitsverliezen         |
| Paramedische zorg                       | Tijdkosten                             | Juridische kosten                |
| Thuiszorg                               | Vitaminepreparaten                     | Speciaal onderwijs               |
| Verpleegdagen                           | Medische hulpmiddelen                  |                                  |
| Polikliniekbezoeken                     |                                        |                                  |
| Ziekenhuisopnames                       |                                        |                                  |

De kosten binnen de gezondheidszorg zijn alle kosten die rechtstreeks verband houden met de preventie, diagnostiek, therapie, revalidatie en verzorging van een ziekte of aandoening. De Nederlandse richtlijnen bevelen aan om ook de zorgkosten in gewonnen levensjaren mee te nemen.

Kosten van patiënten en familie zijn bijvoorbeeld de tijd- en reiskosten van patiënten die direct samenhangen met de behandeling. Ook kosten van mantelzorg vallen in deze categorie.

Kosten in andere sectoren zijn onder andere productieverliezen als gevolg van afwezigheid of inefficiëntie tijdens betaald en onbetaald werk, juridische kosten en kosten van speciaal onderwijs.

De *iPCQ* is gericht op het meten en vervolgens waarderen van productiviteitskosten. Dit is een zeer relevante en niet zelden invloedrijke kostenpost. Gezondheidsproblemen hebben namelijk vaak een negatieve invloed op het vermogen van mensen om betaald of onbetaald werk te verrichten. Vanuit maatschappelijk perspectief kunnen deze productiviteitsverliezen als gevolg van gezondheidsproblemen omvangrijk zijn en zodoende een belangrijke rol spelen in economische evaluaties van gezondheidszorgprogramma's. Daarom is het belangrijk om kosten van productiviteitsverliezen in deze evaluaties op een goede wijze mee te nemen.

Productiviteitsverliezen kunnen worden veroorzaakt door werkverzuim (ziekteverzuim) als gevolg van een gezondheidsprobleem bij betaald werk. Men spreekt dan van absentisme. Dit verzuim kan kortdurend dan wel langdurig van aard zijn. Daarnaast kunnen productiviteitsverliezen optreden zonder dat er sprake is van werkverzuim. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan iemand die ondanks een opkomende migraine besloten heeft toch aan het werk te blijven. Het is dan echter goed mogelijk dat de hoeveelheid of kwaliteit van het werk die op een dergelijke dag wordt gedaan achterblijft bij de hoeveelheid en kwaliteit van het werk die dezelfde persoon op een 'normale' probleemvrije werkdag zou hebben verricht. In dat geval is er sprake ook sprake van productiviteitsverlies, maar zonder verzuim. In de internationale literatuur wordt dit meestal aangeduid als 'presenteeism'.

Productiviteitsverliezen kunnen optreden bij zowel betaald werk als bij onbetaald werk. Als gevolg van gezondheidsproblemen kunnen mensen moeite hebben met het verrichten van onbetaald werk dat een werkelijke, economische waarde vertegenwoordigt, zoals huishoudelijk werk, zorg voor de kinderen of vrijwilligerswerk. Deze 'productie' gaat dan verloren of wordt overgenomen door andere mensen, die hiervoor andere bestedingen van schaarse tijd opofferen. Vanuit de economische definitie van kosten, de zogenoemde opportuniteitskosten, zijn ook onbetaalde productiviteitsverliezen, een relevante, maatschappelijke kostenpost.

## 1.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de *iPCQ*

Voor het meten van de kosten in economische evaluaties wordt frequent gebruik gemaakt van vragenlijsten die door de patiënten, die in de studie zijn geïnccludeerd, zelf moeten worden ingevuld. Alternatieve informatiebronnen voor het meten van productiviteitsverliezen, bijvoorbeeld registraties van Arbodiensten, zijn veelal beperkt tot informatie over de hoeveelheid ziekteverzuim. Vaak zijn de patiënten zelf de enige volledige informatiebron voor het verzamelen van alle gegevens over productiviteitsverliezen.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de *iPCQ* was om op een consistente en gestandaardiseerde manier informatie te verzamelen over productiviteitsverliezen bij betaald en onbetaald werk door middel van zelfrapportage. Standaardisatie heeft als doel om de vergelijkbaarheid tussen en generaliseerbaarheid van studies te vergroten.

De vragen in de *iPCQ* zijn gebaseerd op de Short Form- Health and Labour Questionnaire (SF-HLQ) [2], de PROductivity and DISease Questionnaire (PRODISQ) [3], en de QQ methode [4]. De beste ingrediënten van deze vragenlijsten zijn overgenomen voor de ontwikkeling van de *iPCQ*. De vragenlijst moet geschikt zijn voor zelfrapportage. Een van de voorwaarden voor valide en betrouwbare metingen is de eenduidigheid van de begrippen in de vragen ofwel de begrijpelijkheid van de vragen voor de respondent. Om dit doel te bereiken is een conceptversie van de vragenlijst voorgelegd aan medewerkers van Bureau Taal. Zij hebben de vragen omgezet in eenvoudige Nederlandse teksten (Taalniveau B1). Dat houdt in dat de teksten voor 95% van de mensen te begrijpen is; ook voor mensen met een laag opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden geven vaak de voorkeur aan teksten op een basaal niveau, omdat dit gemakkelijker en sneller leest. Een zogenaamde 'feasibility' studie is uitgevoerd om de consistentie en de begrijpelijkheid van de vragen te toetsen. Dit bevestigde de consistentie en begrijpelijkheid van de *iPCQ* (zie Hoofdstuk 4).

De *iPCQ* is een generieke vragenlijst die dient om de kosten van productiviteitsverliezen te bepalen. De vragenlijst is dus niet ziekte specifiek. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt gerefereerd aan productiviteitsverliezen wegens ziekte of als gevolg van lichamelijke of psychische problemen, zonder een specifiek ziektebeeld te benoemen. Het onderscheiden van productiviteitsverliezen naar specifieke aandoeningen of

behandelingen is voor de patiënt ook niet altijd eenvoudig. Daarom wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van generieke vragen.

De *i*PCQ is zowel toepasbaar voor studies die in Nederland worden uitgevoerd als ook voor internationale studies. De *i*PCQ is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans (zie [www.imta.nl/questionnaires](http://www.imta.nl/questionnaires) voor een volledige lijst van beschikbare vertalingen).

Er is gekozen voor een korte vragenlijst waarin alle vormen van productiviteitsverlies zijn opgenomen.

De *i*PCQ bestaat uit 3 modules:

- productiviteitsverlies bij betaald werk als gevolg van verzuim
- productiviteitsverlies bij betaald werk zonder verzuim
- productiviteitsverlies bij onbetaald werk

Modules waarvan verondersteld kan worden dat deze niet relevant zijn voor de doelgroep, kunnen eventueel worden weggelaten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de *i*PCQ te combineren met een generieke vragenlijst voor het meten van medische consumptie, de iMTA Medical Consumption Questionnaire (*i*MCQ).

### **1.3 Steekproefgrootte, meetmomenten en recall-periode**

De minimale groepsgrootte en het aantal meetmomenten binnen een economische evaluatie hangt van meerdere aspecten af. Voor de kosten is het benodigd aantal respondenten afhankelijk van de verwachte verschillen in kosten tussen de experimentele groep en de controle groep, alsmede van de variatie in kosten in beide groepen. Daarnaast zullen normaliter behalve de kosten ook andere effectmaten in de analyses worden meegenomen (zoals klinische effecten, kwaliteit van leven) die mede bepalend zijn voor het aantal respondenten dat minimaal moet worden geïnccludeerd. Vaak wordt de benodigde power van een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) bepaald op basis van de klinische effectmaten. Bij de berekening van de kosten wordt verondersteld dat de tijdsperiode waarover gemeten wordt representatief is voor de gehele periode tussen twee meetmomenten. Zowel de optimale periode tussen twee meetmomenten, als het aantal metingen tijdens de looptijd van de studie en het aantal benodigde



respondenten is afhankelijk van het verwachte verschil in kosten (en andere effectmaten), het verwachte verloop van de ziekte en de behandeling. In de standaardversie van de *i*PCQ wordt een recall-periode van 4 weken gebruikt. Onderzoek heeft aangetoond dat een langere recall-periode ten koste gaat van de accuraatheid van metingen van ziekteverzuim door middel van zelfrapportage [5]. Daarom moet bij gebruik van een langere recall-periode rekening worden gehouden met een afname van de betrouwbaarheid van de data.

Indien de periode tussen twee meetmomenten langer is dan 4 weken, worden de gegevens d.m.v. extrapolatie aangepast aan het werkelijke tijdsverschil.

## **1.4 Opbouw van de handleiding**

In het volgende hoofdstuk worden achtereenvolgens de algemene opbouw van de *i*PCQ en de verschillende modules van productiviteitsverlies besproken.

In hoofdstuk 3 wordt uitleg gegeven over de scoring en waardering van de verschillende modules. Tevens wordt hierbij ingegaan op de frictiekostenmethode, die met name in Nederland gebruikelijk is voor de waardering van het productiviteitsverlies als gevolg van werkverzuim. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de 'feasibility' studie die is uitgevoerd om de begrijpelijkheid van de vragen te toetsen.

In hoofdstuk 5 vindt u aanwijzingen voor in gebruik name van de *i*PCQ en de voorwaarden voor het gebruik.

De vragenlijst is opgenomen in bijlage I.

## 2. Opbouw iPCQ

De iPCQ kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen. Ook is het mogelijk om de PCQ digitaal te laten invullen. De vragen worden voorafgegaan door een uitgebreide toelichting en een instructie voor het invullen van de vragenlijst voor de respondent. Desgewenst kan de onderzoeker hier relevante aanvullende informatie voor de respondent toevoegen. Aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor opmerkingen van de respondent naar aanleiding van de vragen. De vragenlijst wordt afgesloten met een instructie over het retourneren van de vragenlijst. Deze instructie dient door de onderzoeker te worden aangepast, dan wel worden uitgebreid, voor het specifieke onderzoek.

De iPCQ bestaat uit een aantal onderdelen:

- Algemene vragen (vraag A1 t/m A6)
- Algemene vragen over betaald werk (vraag 1 t/m 3)
- Modules productiviteitsverlies:
  - o Productiviteitsverlies bij betaald werk als gevolg van verzuim(vraag 4 t/m 6)
  - o Productiviteitsverlies bij betaald werk zonder verzuim (vraag 7 t/m 9)
  - o Productiviteitsverlies bij onbetaald werk (vraag 10 t/m12)

De vragenlijst is voorzien van een routing voor de respondent. Vragen die niet van toepassing zijn voor de respondent, kunnen zo eenvoudig worden overgeslagen.

### 2.1 Algemene vragen

Vraag A1 t/m vraag A6 zijn algemene vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan een beschrijving worden gegeven van de onderzoekspopulatie. Ook kunnen de antwoorden eventueel worden gebruikt voor subgroepsanalyses.

Behalve een vraag over de datum van het invullen van de vragenlijst betreffen de algemene vragen de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau en de arbeidsstatus van de respondent.

## 2.2 Algemene vragen over betaald werk

De vragen 1 t/m 3 geven informatie over de hoeveelheid betaald werk (in uren) en over het aantal dagen per week waarop de persoon werkt. Dit laatste geeft inzicht in het gemiddelde aantal uren werk per werkdag van de respondent. Deze informatie is nodig om kosten van productiviteitsverliezen te berekenen.

## 2.3 Modules van productiviteitsverliezen

De vragen over productiviteitsverliezen vormen onderstaande modules:

- Absenteïsme: verzuim van betaald werk (vraag 4 t/m vraag 6)
- 'Presenteeïsme': productiviteitsverliezen tijdens gewerkte dagen (vraag 7 t/m vraag 9)
- Productiviteitsverlies van onbetaald werk (vraag 10 t/m 12)

### 2.3.1 Module 1: Absenteïsme. Verzuim van betaald werk

De vragen 4 t/m 6 gaan over het ziekteverzuim van de respondent. Vraag 4 meet het aantal werkdagen verzuim in de voorafgaande 4 weken.

Figuur 1. Vraag naar werkverzuim in de voorafgaande 4 weken

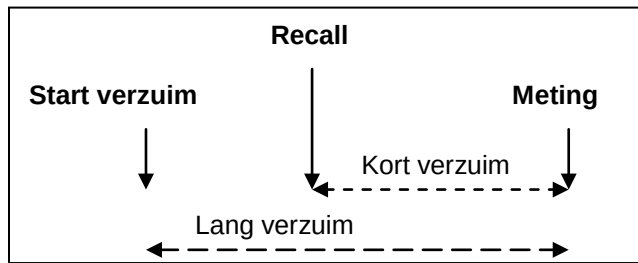
**Vraag 4. Bent u in de afgelopen 4 weken afwezig geweest van uw werk omdat u ziek was?**

☐ Nee

☐ Ja, ik ben ..... dagen afwezig geweest  
(Tel alleen de werkdagen in de afgelopen 4 weken)

De respondent vult hier het aantal werkdagen in dat hij/zij in de afgelopen 4 weken heeft verzuimd. Het verzuim van respondenten die gedurende maximaal 4 weken afwezig zijn geweest noemen we kort verzuim. Als het ziekteverzuim van de respondent al begon voor de recall-periode (vraag 5), wordt gevraagd om de datum van ziekmelding te geven (vraag 6). In dat geval is sprake van lang verzuim.

Figuur 2. Onderscheid kort verzuim en lang verzuim



Figuur 3. Vraag naar datum van ziekmelding bij verzuim langer dan 4 weken

**Vraag 6. Wanneer heeft u zich ziek gemeld?**

dag      maand      jaar  
         

### 2.3.2 Module 2: 'Presenteeism'

Gezondheidsproblemen kunnen resulteren in ziekteverzuim. Het kan echter ook voorkomen dat de gezondheidsklachten weliswaar een lagere productiviteit veroorzaken tijdens het werken, maar niet leiden tot verzuim. Bijvoorbeeld wanneer de klachten niet heel ernstig zijn, zoals in het geval van een milde chronische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 7% van de werknemers aangeeft hinder te ondervinden tijdens het werk van hun gezondheidsproblemen. Soms hangen productiviteitsverliezen op het werk ook samen met (eerder of later) verzuim. Zo vonden Brouwer en collega's dat 25% van de werknemers voorafgaande aan het ziekteverzuim en 20% na het verzuim problemen hadden tijdens het werk [6]. Deze kostencomponent kan aanzienlijk zijn. Vraag 7 t/m 9 meten de hoeveelheid productiviteitsverlies tijdens de uitvoering van betaald werk als gevolg van gezondheidsproblemen. We spreken hierbij dan van 'presenteeism'. De vragen moeten worden ingevuld door alle respondenten die niet hebben verzuimd of niet de volledige 4 weken hebben verzuimd hebben. Vraag 7 maakt een selectie tussen personen die wel en geen hinder hebben ondervonden van gezondheidsproblemen tijdens het uitoefenen van betaald werk. Indien zij aangeven geen hinder te hebben gehad tijdens het werk, zijn er geen productiviteitsverliezen zonder verzuim als gevolg van gezondheidsproblemen. De overige vragen van module 2 mogen dan worden

overgeslagen. Vraag 8 meet het aantal werkdagen waarop de respondent werd gehinderd tijdens het werk. Bij vraag 9 wordt de respondent gevraagd een schatting te geven van de hoeveelheid werk die men op deze dagen kon verrichten in vergelijking met een 'normale' werkdag.

Figuur 4. Vraag naar efficiëntie op gewerkte dagen met hinder van gezondheidsproblemen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                               |   |   |   |                                    |   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|----|--|
| <p><b>Vraag 9. Op de dagen dat u last had, kon u misschien niet zoveel werk doen als normaal. Hoeveel werk kon u op deze dagen gemiddeld doen?</b> Kijk naar de cijfers hieronder. Een 10 betekent dat u op deze dagen net zoveel kon doen als normaal. Een 0 betekent dat u op deze dagen niets kon doen. Zet een cirkel om het goede cijfer.</p> |   |   |   |                               |   |   |   |                                    |   |    |  |
| Ik kon op deze dagen niets doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | Ik kon ongeveer de helft doen |   |   |   | Ik kon net zoveel doen als normaal |   |    |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4                             | 5 | 6 | 7 | 8                                  | 9 | 10 |  |

Deze schatting wordt derhalve uitgedrukt als score variërend van 0 (aanwezig op het werk maar niets kunnen doen) tot 10 (wel gehinderd maar evenveel kunnen doen als op een normale werkdag).

### 2.3.3 Module 3: Productiviteitsverlies van onbetaald werk

Vraag 10 tot en met vraag 12 gaan over het productiviteitsverlies bij onbetaald werk. Een respondent kan zodanig worden gehinderd door gezondheidsproblemen dat hij/zij normale onbetaalde werkzaamheden, zoals huishoudelijk werk of vrijwilligerswerk, gedeeltelijk of geheel niet heeft kunnen uitvoeren. Vraag 10 is een selectievraag. Respondenten die geen hinder hebben ondervonden van hun gezondheidsklachten bij het uitvoeren van onbetaalde werkzaamheden kunnen vraag 11 en 12 overslaan. Vraag 11 meet het aantal dagen waarop de respondent minder onbetaald werk heeft kunnen verrichten als gevolg van de gezondheidsproblemen. Vervolgens wordt gevraagd om een schatting te geven van het verloren aantal uur onbetaald werk. Dit wordt gedaan door een schatting te vragen van het gemiddelde aantal uren per dag dat een familielid of een bekende nodig zou hebben om haar/hem op deze dagen te helpen (vraag 12).

Figuur 5. Vraag naar de hoeveelheid productiviteitsverlies van onbetaald werk

**Vraag 12. Stel dat iemand, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een bekende, u op deze dagen had geholpen. En al het onbetaalde werk wat u niet kon doen, voor u had gedaan. Hoeveel uur was die persoon hier op deze dagen dan gemiddeld mee bezig geweest?**

Gemiddeld ..... uur op deze dagen

### 3. Scoring en waardering van productieverliezen

Om de kosten van productiviteitsverliezen te berekenen worden volumina vermenigvuldigd met kostprijzen per eenheid. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over het scoringssysteem van de verschillende modules van de *i*PCQ en de methoden van waardering die kunnen worden gebruikt om vervolgens de kosten te berekenen. De kosten per eenheid worden gewaardeerd aan de hand van standaardkostprijzen. Voor meer informatie over de waardering van kosteneenheden wordt verwezen naar de Handleiding voor kostenonderzoek in de gezondheidszorg [7].

#### 3.1 Module 1: Absenteïsme. Verzuim van betaald werk

##### 3.1.1 Scoring

In module 1 wordt onderscheid gemaakt in kort verzuim en lang verzuim. Kort verzuim wordt gemeten aan de hand van het aantal werkdagen dat de respondent heeft verzuimd gedurende de voorafgaande 4 weken (vraag 4).

Wanneer de verzuimperiode niet langer is geweest dan de voorafgaande 4 weken kan het aantal werkdagen productiviteitsverlies worden bepaald aan de hand van het antwoord op vraag 4. Het minimum aantal werkdagen verzuim is '0' en het maximum aantal werkdagen is theoretisch '28'. Echter, het merendeel van de respondenten zal maximaal 5 dagen per week werken, met maximaal 20 werkdagen verzuim in de voorafgaande 4 weken. Het aantal uren per werkdag wordt berekend door het aantal uren per werkweek (vraag 2) te delen door het aantal dagen (vraag 3) dat de respondent per week werkt. De totale hoeveelheid verzuim wordt vervolgens berekend door vermenigvuldiging van het aantal dagen verzuim en het aantal uren per werkdag van de respondent.

Bij respondenten die aangeven dat het verzuim langer heeft geduurd dan 4 weken, wordt de hoeveelheid verzuim bepaald aan de hand van de gegevens op vraag 6. Lang verzuim wordt gemeten in kalenderdagen door berekening van het aantal dagen verschil tussen de datum van invullen van de *i*PCQ en de datum van ziekmelding (vraag 6).

Voor respondenten met lang verzuim moet een correctie worden aangebracht op de score van het kort verzuim (vraag 4) om dubbeltelling te voorkomen. Immers, de respondent vult eerst in op hoeveel werkdagen hij/zij in de voorafgaande 4 weken heeft verzuimd en

vervolgens wordt informatie over lang verzuim gevraagd. Daarom moet bij de respondenten die langer dan 4 weken hebben verzuimd het kort verzuim dat bij vraag 4 is gerapporteerd op 0 worden gezet.

### 3.1.2 Waardering

Bij de bepaling van de waarde van de verloren productie door verzuim van betaald werk zijn verschillende benaderingen mogelijk. De meest gebruikte methoden zijn de frictiekostenmethode (FKM) en de human capital methode (HCM). De keuze voor een specifieke waarderingsmethode kan grote gevolgen hebben voor de uitkomsten van een economische evaluatie en dient derhalve goed te worden doordacht en verantwoord. De discussie over welke waarderingsmethode 'beter' is, is nog in volle gang. In Nederland wordt de FKM aanbevolen. Dit hangt samen met het feit dat de FKM goed aansluit bij het maatschappelijk perspectief [1]. Een belangrijk argument tegen het gebruik van de HCM in economische evaluaties is juist dat waardering volgens deze methode uitgaat van een individualistisch patiëntperspectief [8].

Productiviteitskosten kunnen als volgt worden gedefinieerd:

*'productiviteitsverliezen en/of kosten welke gemaakt worden om het productieniveau te kunnen handhaven als gevolg van ziekte en behandeling van de werknemer' [9]*

De FKM gaat uit van de gedachte dat binnen het productieproces mensen vervangbaar zijn. Vanuit maatschappelijk perspectief zijn, bij afdoende vervangingsmogelijkheden, productiviteitsverliezen daarom tijdelijk en beperken zich met name tot de verliezen in de periode die nodig is om een vacature op te vullen. Deze periode wordt de frictieperiode genoemd. Wanneer de duur van het verzuim van een persoon de frictieperiode overtreft zijn de gerelateerde productiviteitsverliezen beperkt tot de duur van de frictieperiode. Met andere woorden, na die periode is de afwezige persoon vervangen en treden geen verdere productiviteitsverliezen meer op. De lengte van de frictieperiode is derhalve afhankelijk van de snelheid waarmee een vacature kan worden opgevuld. Dit laatste is vervolgens weer afhankelijk van o.a. de werkeloosheid en de mate van mobiliteit op de arbeidsmarkt. De vacatureduur is een indicatie voor de lengte van de frictieperiode. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een extra periode, die op circa 4 weken is geschat, voordat wordt besloten maatregelen te nemen om het productiviteitsverlies te



herstellen. De frictieperiode is daarmee gelijk aan de geschatte vacatureduur plus 4 weken. Voor meer bijzonderheden over de FKM wordt verwezen naar Koopmanschap en Rutten [10]. Voor de waardering van de kosten van productiviteitsverlies wordt gebruik gemaakt van de standaard kostprijs van productiviteit per uur. De meest actuele informatie over de duur van de frictieperiode en standaard kostprijzen van productiviteit is te vinden in de Handleiding voor Kostenonderzoek [7].

### **Berekening kosten van productiviteitsverlies bij kort verzuim**

Het aantal werkdagen dat is verzuimd gedurende de afgelopen 4 weken wordt vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal uren per werkdag van de respondent (vraag 2/vraag 3) en de standaard kostprijs van productiviteitskosten per uur.

Als de recall-periode als representatief kan worden beschouwd voor de periode tussen twee achtereenvolgende meetmomenten, kunnen de resultaten d.m.v. extrapolatie worden aangepast naar de duur van de periode tussen de twee meetmomenten.

#### **Voorbeeld berekening kosten productiviteitsverlies bij kort verzuim**

Respondent A werkt 24 uur per week verdeeld over 3 dagen per week. Een werkdag bestaat dus gemiddeld uit 8 uur. De respondent heeft in de afgelopen 4 weken 2 dagen verzuimd. We gaan uit van een productiviteitswaarde van €30 per uur.

De kosten van het verzuim gedurende de recall-periode van 4 weken zijn dan:  
 $2 \text{ dagen} * 8 \text{ uur per werkdag} * € 30 = € 480$ .

Tussen de opeenvolgende metingen ligt een periode van 6 maanden ofwel 26 weken. D.m.v. extrapolatie worden de totale kosten over deze periode als volgt berekend:  
 $(26 \text{ weken} / 4 \text{ weken recall} =) 6,75 * € 480 = € 3240$ .

## **Berekening van kosten van productiviteitsverlies bij lang verzuim**

De productiviteitskosten van lang verzuim worden bepaald door het moment van aanvang van het verzuim in combinatie met de lengte van de periode tussen opeenvolgende meetmomenten.

Hierbij kunnen 3 verschillende situaties ontstaan die van invloed zijn op de berekening van het productiviteitsverlies volgens FKM:

- 1) De totale verzuimduur is langer dan 4 weken maar korter dan de frictieperiode
- 2) De verzuimduur is langer dan de frictieperiode, maar een deel van de frictieperiode valt in de periode tussen de 2 opeenvolgende meetmomenten.
- 3) De verzuimduur is langer dan de frictieperiode én de gehele frictieperiode ligt vóór het tijdstip van de voorafgaande meting.

De verschillende situaties worden gepresenteerd aan de hand van een voorbeeld en een grafische weergave van de situatie en de bijbehorende berekeningen van kosten van productiviteitsverlies. In tegenstelling tot kort verzuim, dat gemeten wordt in werkdagen, wordt de hoeveelheid lang verzuim uitgedrukt in kalenderdagen. Daarom moet voor de berekening van de kosten van productiviteitsverlies bij lang verzuim het aantal kalenderdagen verzuim omgerekend worden naar het aantal werkweken verzuim om het aantal werkdagen verzuim te bepalen.

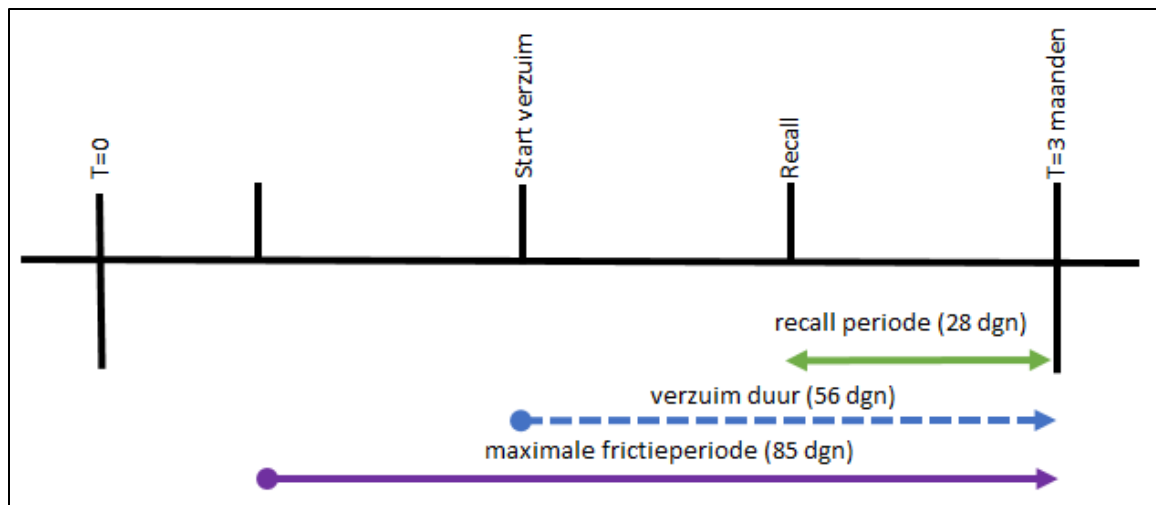
### ***Situatie 1: de verzuimduur is korter dan de frictieperiode***

Respondent B werkt 24 uur per week verdeeld over 4 dagen (respondent B werkt dus 6 uur per werkdag). Respondent B heeft langer dan 4 weken verzuimd. Op basis van de start van het verzuim, vermeld bij vraag 6, is de totale duur van het verzuim berekend op 56 (kalender)dagen.

We gaan uit van een productiviteitswaarde van €30 per uur en een frictieperiode van 85 dagen.

De periode tussen de huidige meting en de voorafgaande meting is 3 maanden (91 dagen).

Figuur 6. De verzuimduur is korter dan de frictieperiode



De kosten van het verzuim worden direct berekend voor de gehele periode tussen de meetmomenten. De duur van het verzuim is korter dan de frictieperiode van 85 dagen. Daarom worden de kosten van productiviteitsverlies voor de hele periode van het verzuim berekend.

56 kalenderdagen verzuim =  $56/7 = 8$  werkweken =  $8 \times 4 = 32$  werkdagen.

De kosten van verzuim tussen de 2 opeenvolgende meetmomenten bedragen dan:

$32 \text{ werkdagen} \times 6 \text{ uur per dag} \times \text{€}30 = \text{€}5760$ .

***Situatie 2: de verzuimduur is langer dan de frictieperiode, maar een deel van de frictieperiode valt in de periode tussen de 2 opeenvolgende meetmomenten***

Respondent C werkt 36 uur per week verdeeld over 4 dagen per week. Een werkdag bestaat dus gemiddeld uit 9 uur. Het verzuim van respondent C op basis van de start van het verzuim is op het moment van de meting 120 kalenderdagen.

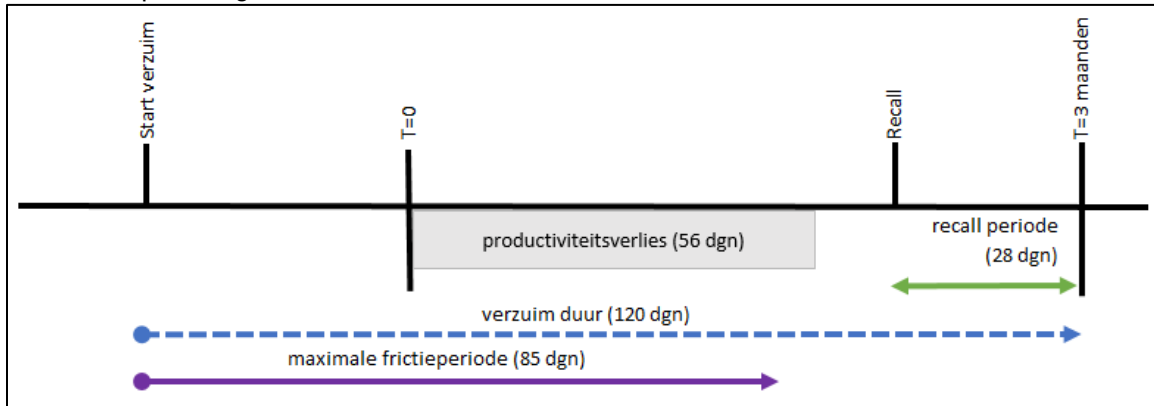
De periode tussen de huidige meting en de voorafgaande meting is 3 maanden (91 dagen). De standaard kostprijs van 1 uur productiviteit bedraagt €30 en de frictieperiode is 85 dagen.

In deze situatie moet rekening worden gehouden met de volgende zaken van belang:  
 Het verzuim van deze respondent is al begonnen voor het tijdstip waarop de eerste meting ( $T=0$ ) plaats vond. Het verzuim is gestart 29 dagen voor  $T=0$ . Dat betekent dat de kosten van deze eerste 29 dagen van het verzuim al zijn berekend op  $T=0$ . Dat betekent dat de kosten van het verzuim beperkt zijn voor de duur van 91 dagen (de periode tussen de eerste en de tweede meting).

De frictieperiode start op het moment dat het verzuim ingaat. Op het tijdstip van de eerste meting zijn dus ook al 29 dagen van de frictieperiode verstreken. (Zie figuur 7)

M.a.w. bij de berekening van de kosten van productiviteitsverlies voor situatie 2 moet dus rekening worden gehouden met het aantal dagen verzuim in de periode tussen de opeenvolgende metingen die nog behoren tot de frictieperiode.

Figuur 7. De verzuimduur is langer dan de frictieperiode. Een deel van de frictieperiode valt tussen de opeenvolgende meetmomenten



De berekening van de kosten van productiviteitsverlies is dan als volgt:

#### *Berekening productiviteitskosten situatie 2 (vervolg)*

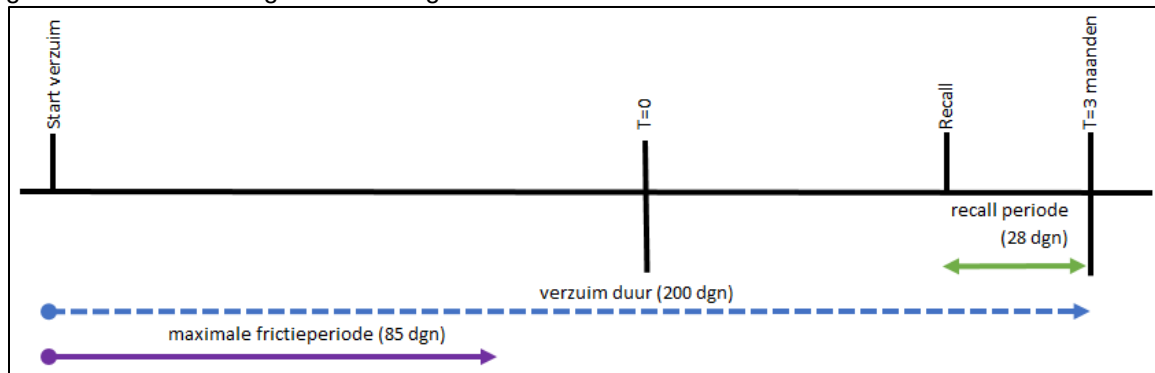
- Het totale verzuim van de respondent is 120 dagen
- Het aantal dagen verzuim tussen T=0 en T= 3 maanden is 91 dagen
- De eerste 29 dagen van het verzuim van deze respondent vallen dus buiten de periode waarover kosten van T=3 maanden worden berekend
- Het totale verzuim is langer dan de frictieperiode. Dus de kosten worden voor maximaal 85 dagen berekend (= de duur van de frictieperiode)
- De frictieperiode start op het moment dat het verzuim begint
- De kosten van de eerste 29 dagen van het verzuim zijn al berekend bij de eerste meting (T=0)
- Het resterend aantal dagen van de frictieperiode tussen de eerste meting (T=0) en de tweede meting (T=3 maanden) is nu  $85 - 29 = 56$  kalenderdagen (ofwel 8 werkdagen). Over deze periode worden dus kosten van productieverlies berekend.

De kosten van verzuim tussen T=0 en T=3 maanden in dit voorbeeld bedragen dan:  
 $8 \text{ weken} * 4 \text{ werkdagen} * 9 \text{ uur per werkdag} * €30 = €8.640.$

**Situatie 3. De verzuimduur is langer dan frictieperiode en de hele frictieperiode ligt voor de voorafgaande meting**

Respondent D werkt 24 uur per week verdeeld over 3 dagen. Het verzuim van respondent D op basis van de start van het verzuim is op het moment van de meting 200 kalenderdagen. De periode tussen de huidige meting en de voorafgaande meting is 6 maanden (=91 dagen).

Figuur 8. De start van het verzuim ligt voor de voorafgaande meting en de frictieperiode ligt geheel voor de voorafgaande meting



De frictieperiode ligt geheel voor de datum waarop de voorafgaande meting (meting 1) is uitgevoerd (200 verzuim - 85 dagen frictieperiode = 115 dagen vóór meting 2; de periode tussen meting 1 en 2 is 91 dagen).

Voor deze situatie geldt voor de berekening dat, als het aantal dagen verzuim groter is dan het aantal dagen van de frictieperiode plus het aantal dagen tussen de 2 meetmomenten, de additionele kosten van het productiviteitsverlies €0 zijn.

In bovenstaand voorbeeld is het aantal dagen van de frictieperiode (85) + het aantal dagen tussen de opeenvolgende meetmomenten (91)= 176.

Tenslotte nog een algemene opmerking. Bij metingen die elke 4 weken worden uitgevoerd kunnen berekeningen op individueel niveau worden uitgevoerd. Immers, een extrapolatie naar opeenvolgende meetmomenten is dan overbodig. In de praktijk zullen de opeenvolgende metingen echter een langere periode beslaan. De berekeningen d.m.v. extrapolatie gelden dan alleen op geaggregeerd niveau en niet op individueel niveau.

### 3.2 Module 2: 'Presenteeism'

### 3.2.1 Scoring

Voor de berekening van de hoeveelheid productiviteitsverlies zonder verzuim van betaald werk wordt het aantal gewerkte dagen met hinder vermenigvuldigd met 'één minus de efficiëntie gedeeld door 10' voor deze dagen.

Vraag 8 meet het aantal werkdagen waarop de respondent werd gehinderd door gezondheidsproblemen. Afhankelijk van het aantal dagen dat de respondent per week werkt is het minimum aantal werkdagen 0 en het maximum (theoretisch) 28. Het productiviteitsverlies wordt berekend o.b.v. de efficiëntie van de respondent op deze werkdagen, die wordt bepaald aan de hand van de scores op vraag 9.

De formule voor het berekenen van het aantal uren productiviteitsverlies bij 'presenteïsme' is:

$$\text{Aantal werkdagen hinder} * [1 - (\text{efficiëntie score}/10)] * \text{aantal uur per werkdag}$$

**Voorbeeld.** Een respondent geeft aan dat hij/zij 3 werkdagen last heeft gehad van gezondheidsproblemen en de efficiëntie op deze dagen werd gewaardeerd met een 8. Een werkdag van de respondent bedraagt 8 uur. De hoeveelheid productiviteitsverlies is dan gelijk aan  $3 * (1 - (8/10)) * 8 = 0.6$  werkdag ofwel 4,8 uur.

### 3.2.2 Waardering

De kosten van 'presenteïsme' worden berekend door het aantal uren productiviteitsverlies te vermenigvuldigen met de standaard kostprijs van productiviteit.

## 3.3 Module 3: Productiviteitsverlies van onbetaald werk

### 3.3.1 Scoring

Vraag 10 maakt een selectie tussen respondenten die wel en niet minder onbetaald werk hebben kunnen doen als gevolg van hun gezondheidsproblemen. De hoeveelheid productiviteitsverlies van onbetaald werk wordt bepaald door het aantal dagen verlies (vraag 11) te vermenigvuldigen met het aantal uren hulp per dag dat nodig is om dit werk in te halen (vraag 12).

### **3.3.2 Waardering**

De kosten van productiviteitsverlies van onbetaald werk worden berekend door de hoeveelheid productiviteitsverlies te vermenigvuldigen met een standaard uurtarief van huishoudelijke zorg (zie Handleiding voor Kostenonderzoek in de gezondheidszorg [7]).

## 4. Feasibility en validiteit

De *iPCQ* is ontwikkeld op basis van vragen die afkomstig zijn van de SF-HLQ en de PRODISQ. In een aantal studies is de validiteit van het meten van verzuim van betaald werk beoordeeld [2,11,12]. Voor informatie over de validiteit voor de berekening van productiviteitsverlies zonder verzuim wordt verwezen naar Brouwer et al. [4] De vragen over productiviteitsverlies van onbetaald werk zijn tot stand gekomen o.b.v. brainstorm sessies binnen de werkgroep Productivity and Health Research van het iMTA. Meer onderzoek is nodig om de validiteit van deze module te bepalen.

De betrouwbaarheid van data die worden verzameld d.m.v. zelfrapportage is mede afhankelijk van de begrijpelijkheid van de vragen voor de patiënt. Onderzoekers zijn vaak 'gebiast' door hun informatiebehoefte en hun kennis wat van invloed kan zijn op de manier van formulering van vragenlijsten. De vragen van de *iPCQ* zijn door een gespecialiseerd bureau 'vertaald' een eenvoudig Nederlands taalniveau.

Vervolgens is een feasibility studie uitgevoerd om de toepasbaarheid van de vragen te bepalen [13]. In deze feasibility studie werd gevraagd om de vragenlijst volledig in te vullen en om aan te geven welke vragen onduidelijk werden gevonden. Tevens zijn er tijdmetingen uitgevoerd om te bepalen hoeveel tijd de respondent nodig had om de *iPCQ* in te vullen. In totaal hebben 195 respondenten van 18 jaar en ouder deelgenomen aan deze studie. Hiervan was 36% man. 10% van deze groep was laag opgeleid, 25% had een middelbare opleiding afgerond. 62% van de respondenten gaf aan betaald werk te hebben. Binnen de groep met betaald werk gaf 30% aan gehinderd te zijn door gezondheidsklachten tijdens de uitvoering van betaald werk. 10% had in de voorafgaande 4 weken moeten verzuimen van werk. Het aantal respondenten dat problemen had ondervonden bij het invullen van de vragenlijst was gering. Een aantal respondenten gaf aan de routing van kort naar lang verzuim niet duidelijk te vinden. De instructie bij de vraag is hiervoor aangepast. Tenslotte werd de inschatting van de tijd die nodig zou zijn om het verlies aan onbetaald werk door anderen te laten doen door een aantal respondenten (n=8) als lastig omschreven. Aangezien een bruikbaar alternatief hiervoor momenteel niet beschikbaar is, is deze vraag gehandhaafd.

De gemiddelde tijd voor het invullen van de *iPCQ* was ca. 5 minuten.



## 5. Gebruik van de *i*PCQ

### 5.1 Algemeen

De *i*PCQ kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om de *i*PCQ digitaal te laten invullen. De instructie die aan de vragenlijst voorafgaat en de instructie voor het retourneren van de vragenlijst moeten door de onderzoeker verder worden aangepast naar de specifieke context van uitvoering van het onderzoek. Modules die niet relevant worden geacht voor de doelgroep kunnen eventueel worden weggelaten. Voor kortdurende episodes van ziekteverzuim kan desgewenst gebruik worden gemaakt van een verfijndere meetmethode. Bepaalde chronische aandoeningen kunnen een sterk wisselende invloed hebben op het verzuim voor de patiënt. Bijvoorbeeld, patiënten met migraine kunnen de ene dag wel in staat zijn om te werken en de volgende dag niet naar hun werk kunnen komen. Ook kan het zijn dat zij last kunnen krijgen tijdens het werk, waardoor zij eerder naar huis moeten. Door het sterk wisselende verzuim is het lastig om de totale hoeveelheid verzuim per periode te rapporteren. Het gebruik van een dagboekje om het verzuim te herinneren kan daarbij behulpzaam zijn. In bijlage III is een vraag opgenomen in de vorm van een dagboekje over het werkverzuim (vraag 4a). De vraag is afkomstig van de Health & Labour Questionnaire (HLQ) en wordt als aanvulling gebruikt bij vraag 4. In dit geval wordt in vraag 4 alleen gevraagd of de respondent ziek is geweest. Respondenten die 'ja' hebben ingevuld gaan dan verder met vraag 4a (zie Bijlage II).

### Follow-up metingen

De *i*PCQ bevat 6 algemene vragen. Bij de toepassing van de *i*PCQ op meerdere meetmomenten kan het aantal algemene vragen in de follow-up metingen worden beperkt. Echter, vraag A1 (datum van invullen van de vragenlijst) en vraag A6 moeten voor elk meetmoment worden opgenomen.

## 5.2 Gebruikersvoorwaarden

De vragenlijst is ontwikkeld door het instituut voor Medical Technology Assessment, (iMTA), Erasmus Universiteit Rotterdam. De vragenlijst kan gebruikt worden onder de volgende condities:

- Voor gebruik van de vragenlijst dient u vooraf **toestemming** te vragen. Een aanvraag voor gebruik van de vragenlijst gebeurt door het online invullen van het registratieformulier dat te vinden is op de website van iMTA ([www.imta.nl/questionnaires](http://www.imta.nl/questionnaires)). U ontvangt dan z.s.m. van ons een bericht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de vragenlijst te kopiëren en/of te verspreiden.
- Aan het gebruik van de vragenlijst door wetenschappelijke instellingen zijn geen financiële consequenties verbonden. Voor onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd door een commerciële organisatie wordt een licentiebedrag gerekend. Het licentiebedrag is afhankelijk van type studie, grootte van de populatie en duur van de studie en wordt bepaald op basis van informatie uit het registratieformulier. Toestemming wordt verleend na ontvangst van het licentiebedrag. Na registratie bent u niet verplicht tot aankoop.
- De notitie voor auteursrechten, welke op de titelpagina staat van deze handleiding, dient overgenomen te worden in geval de vragenlijst wordt gebruikt.
- De bron dient als volgt expliciet in publicaties vermeld te worden:  
[www.imta.nl](http://www.imta.nl) (iMTA Productivity and Health Research Group. Handleiding iMTA Productivity Cost Questionnaire (iPCQ). Rotterdam: iMTA, Erasmus Universiteit, 2018)
- Veranderingen in de vragenlijst mogen worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming. In de rapportage van de studie moet worden vermeld dat gebruik is gemaakt van een aangepaste versie van deze vragenlijst.
- Uitsluiting van aansprakelijkheid: de gebruiker dient het instituut for Medical Technology Assessment (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de auteurs van deze uitgave te vrijwaren voor schadeclaims van derden ontstaan door en/of gerelateerd aan het gebruik van deze uitgave door de gebruiker in geval van wijziging en/of vertalingen of door fouten, weglatingen en misinterpretaties of enige consequenties hiervan.

- De gebruiker dient een referentie van manuscripten, artikelen of overige publicaties waarin resultaten van dit instrument worden vermeld aan de auteurs ter beschikking te stellen.

## 6. Referenties

1. Zorginstituut Nederland. Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg. 2016.
2. Van Roijen L, Essink-Bot ML, Koopmanschap MA, Bonsel G, Rutten FFH. Labor and health status in economic evaluation of health care: The Health and Labor Questionnaire. *Int J Technol Assess Health Care*. 1996;12: 405-415.
3. Koopmanschap MA. PRODISQ: a modular questionnaire on productivity and disease for economic evaluation studies. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res*. 2005;5: 23-28.
4. Brouwer WB, Koopmanschap MA, Rutten FF. Productivity losses without absence: measurement validation and empirical evidence. *Health Policy*. 1999;48: 13-27.
5. Severens JL, Mulder J, Laheij RJF, Verbeek ALM. Precision and accuracy in measuring absence from work as a basis for calculating productivity costs in The Netherlands. *Soc Sci Med*. 2000;51: 243-249.
6. Brouwer WB, van Exel NJ, Koopmanschap MA, Rutten FF. Productivity costs before and after absence from work: as important as common? *Health Policy*. 2002;61: 173-187.
7. Hakkaart-van Roijen L, Van der Linden N, Bouwmans CAM, Kanter TA, Tan SS. *Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en referentiepreisen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg*. 2015.
8. Brouwer WBF, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Productivity costs in cost-effectiveness analysis: numerator or denominator: a further discussion. *Health Econ*. 1997;6: 511-514.
9. Brouwer WBF, Koopmanschap MA. How to calculate indirect costs in economic evaluations. *Pharmacoeconomics*. 1998;13: 563-566.
10. Koopmanschap MA, Rutten FFH. A practical guide for calculating indirect costs of disease. *Pharmacoeconomics*. 1996;10: 460-466.
11. Bouwmans C, De Jong K, Timman R, Zijlstra-Vlasveld M, Van der Feltz-Cornelis C, Tan SS, et al. Feasibility, reliability and validity of a questionnaire on healthcare consumption and productivity loss in patients with a psychiatric disorder (TiC-P). *BMC Health Serv Res*. 2013;13: 217.
12. Meerding WJ, IJzelenberg W, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity loss at work among workers with high physical load jobs. *J Clin Epidemiol*. 2005;58: 517-523.
13. Bouwmans C, Krol M, Severens H, Koopmanschap M, Brouwer W, Hakkaart-van Roijen L. The iMTA Productivity Cost Questionnaire: A Standardized Instrument for

Measuring and Valuing Health-Related Productivity Losses. Value Health. 2015;18: 753-758.

## **Bijlage I Vragenlijst iPCQ**

## Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Onderzoekers noemen deze vragenlijst de iMTA PCQ.



## **Toelichting**

### **Lees dit alstublieft eerst!**

#### **Voor wie is deze vragenlijst?**

Deze vragenlijst is voor u. Er zijn verschillende mogelijkheden:

- U heeft de lijst van uw huisarts of in het ziekenhuis gekregen.
- U heeft de lijst per post gekregen en uw naam staat op de envelop.

#### **Kunt u de lijst niet zelf invullen?**

Als u de lijst niet zelf kunt invullen, kan iemand u misschien helpen. Bijvoorbeeld een familielid.

#### **Waar gaat de vragenlijst over?**

De vragenlijst gaat over uw gezondheid en werk in de afgelopen 4 weken. We beginnen met algemene vragen. Bijvoorbeeld over uw geslacht en geboortedatum.

#### **Hoe lang duurt het om de lijst in te vullen?**

Het duurt ongeveer 10 minuten om de lijst in te vullen.

#### **Hoe moet u de lijst invullen?**

- Begin bij de eerste vraag en volg de nummering.
- Kruis voor iedere vraag 1 hokje aan, behalve als er bij de vraag staat dat u meer dan 1 hokje mag aankruisen.
- Bij sommige vragen kunt u een getal of iets anders invullen op de stippellijn.
- U kunt geen foute antwoorden geven.



**Wilt u een antwoord veranderen?**

- Streep het oude antwoord door.
- Kruis een nieuw antwoord aan.
- Zet een pijl voor het nieuwe antwoord.

☒ ~~oud antwoord~~

→ ☒ nieuw antwoord

**Wat gebeurt er met uw antwoorden?**

Uw antwoorden worden gebruikt voor onderzoek. Alleen de onderzoekers zien uw antwoorden. Dus niemand anders.

De onderzoekers schrijven uw naam nergens op. En zij vertellen aan niemand dat u aan het onderzoek heeft meegewerkt.

**Fijn dat u de lijst voor ons wilt invullen!**

## Algemene vragen

**Vraag A1. Op welke datum vult u deze vragenlijst in?**

| dag                  |                      | maand                |                      | jaar                 |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Vraag A2. Wat is uw geboortedatum?**

| dag                  |                      | maand                |                      | jaar                 |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Vraag A3. Wat is uw geslacht?**

- ☐ Man  
☐ Vrouw

**Vraag A4. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?** Zoek uw hoogste opleiding en kruis het hokje daarvoor aan.

- ☐ Ik heb geen school of opleiding afgemaakt  
☐ Lagere school of basisschool  
☐ Huishoudschool, vbo, lbo, lts, leao of lhno  
  
☐ Mavo, mulo, ivo of vmbo  
☐ Mbo, mts, meao, mhno, inas of intas  
☐ Havo, vwo, hbs, mms, atheneum of gymnasium  
  
☐ Hbo, hts, heao of hhno  
☐ Universiteit  
☐ Ik heb een andere opleiding afgemaakt, namelijk .....

.....

**Vraag A5. Wat doet u in het dagelijks leven?** Kruis aan wat u de meeste tijd doet.

- ☐ Ik zit op school, ik studeer
- ☐ Ik werk in loondienst
- ☐ Ik ben zelfstandig ondernemer
- ☐ Ik ben huisvrouw, huisman
  
- ☐ Ik ben werkloos
- ☐ Ik ben arbeidsongeschikt, voor ... %
- ☐ Ik ben met pensioen of prepensioen
- ☐ Ik doe iets anders, namelijk .....

.....

**Vraag A6. Hebt u betaald werk?**

- ☐ Nee
- ☐ Ja

De volgende vragen gaan over uw baan. Dus over werk waarvoor u betaald wordt. Hebt u geen betaalde baan? Ga dan verder met vraag 10. *Lees eerst de toelichting boven vraag 10.*

**Vraag 1. Wat is uw beroep?**

.....

**Vraag 2. Hoeveel uur per week werkt u?** Tel alleen de uren waarvoor u betaald wordt.

..... uren

**Vraag 3. Op hoeveel dagen in de week werkt u?**

Op ..... dagen

**Vraag 4. Bent u in de afgelopen 4 weken afwezig geweest van uw werk omdat u ziek was?**

- ☐ Nee  
☐ Ja, ik ben ..... dagen afwezig geweest  
(Tel alleen de werkdagen in de afgelopen 4 weken)

Heeft u "Ja" aangekruist? Beantwoord dan vraag 5.  
Ga anders verder met vraag 7.

**Vraag 5. Was u langer dan de gehele periode van 4 weken afwezig van uw werk doordat u ziek was?** Het gaat om een aaneengesloten periode van werkverzuim.

- ☐ Nee  
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 6.  
Ga anders verder met vraag 7.

**Vraag 6. Wanneer heeft u zich ziek gemeld?**

| dag                  | maand                | jaar                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Ga verder met vraag 10. *Lees eerst de toelichting boven vraag 10.*

**Vraag 7. Waren er in de afgelopen 4 weken dagen waarop u wel gewerkt heeft, maar tijdens uw werk last had van lichamelijke of psychische problemen?**

- ☐ Nee  
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 8 en 9.  
Ga anders verder met vraag 10. *Lees eerst de toelichting boven vraag 10.*

**Vraag 8. Op hoeveel werkdagen had u tijdens uw werk last van uw lichamelijke of psychische problemen?** Tel alleen de werkdagen in de afgelopen 4 weken.

..... werkdagen

**Vraag 9. Op de dagen dat u last had, kon u misschien niet zoveel werk doen als normaal. Hoeveel werk kon u op deze dagen gemiddeld doen?** Kijk naar de cijfers hieronder. Een 10 betekent dat u op deze dagen net zoveel kon doen als normaal. Een 0 betekent dat u op deze dagen niets kon doen. Zet een cirkel om het goede cijfer.

Ik kon op  
deze dagen  
niets doen

Ik kon onge-  
veer de helft  
doen

Ik kon net  
zoveel doen  
als normaal

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

### **Toelichting**

Ook bij onbetaald werk, kunt u last hebben van uw lichamelijke of psychische problemen. Soms kunt u daardoor minder doen. U kunt bijvoorbeeld niet goed voor de kinderen zorgen of vrijwilligerswerk doen. Of geen boodschappen doen of in de tuin werken. Daarover gaan de volgende vragen.

**Vraag 10. Waren er dagen waarop u minder onbetaald werk kon doen door uw lichamelijke of psychische problemen?** Het gaat om dagen in de afgelopen 4 weken.

- ☐ Nee  
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 11 en 12.  
Ga anders naar het einde van de vragenlijst.

**Vraag 11. Op hoeveel dagen was dit zo?** Tel alleen de dagen in de afgelopen 4 weken.

.... dagen

**Vraag 12. Stel dat iemand, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een bekende, u op deze dagen had geholpen. En al het onbetaalde werk wat u niet kon doen, voor u had gedaan. Hoeveel uur was die persoon hier op deze dagen dan gemiddeld mee bezig geweest?**

Gemiddeld ..... uur op deze dagen

**Dit was de laatste vraag.**

**Heeft u vragen of opmerkingen?**

Misschien heeft u nog vragen of opmerkingen? Schrijft u deze dan hieronder op.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Wat moet u doen met de ingevulde vragenlijst?**

Heeft u alles ingevuld? Doe de vragenlijst dan in de envelop. Er hoeft geen postzegel op. Doe de envelop alstublieft snel op de post. In elk geval vóór xxx.

Bent u de envelop kwijtgeraakt? Dan kunt u de vragenlijst in een andere envelop zonder postzegel sturen naar:

xxx  
xxx  
xxx

**Hartelijk dank!**



## **Bijlage II**

### **Optionele vraag**

De volgende vragen zijn een alternatief voor vraag 4 in de standaard PCQ.

**Vraag 4. Bent u in de afgelopen 4 weken afwezig geweest van uw werk omdat u ziek was?**

- ☐ Nee  
☐ Ja

*Heeft u “Nee” ingevuld? Ga dan verder met vraag 7*

**Vraag 4a. Hoeveel dagen heeft u niet kunnen werken doordat u ziek was?**

Het gaat om dagen in de afgelopen 4 weken. Gebruik de schema's hieronder om deze vraag te beantwoorden. U ziet eerst een voorbeeld.

**Voorbeeld**

Het voorbeeld gaat over mevrouw De Groot. Mevrouw De Groot werkt 4 dagen per week. Op woensdag en in het weekend is zij altijd vrij. Vorige week was zij een paar dagen ziek. We vullen het schema hieronder voor haar in. We vullen bij iedere dag in of mevrouw De Groot die ochtend of die middag **gewerkt** heeft, **vrij** was of **ziek** was.

- Mevrouw De Groot heeft vorige week maandagochtend gewerkt. In het vakje onder *maandag*, bij *ochtend*, schrijven we **gewerkt**.
- Aan het eind van de ochtend werd mevrouw De Groot ziek en tussen de middag is ze naar huis gegaan. Maandagmiddag en de hele dinsdag heeft ze niet gewerkt, omdat ze ziek was. In de vakjes bij maandagmiddag, dinsdagochtend en dinsdagmiddag schrijven we **ziek**.
- Woensdag was mevrouw De Groot de hele dag vrij. Ze was toen nog ziek, maar dat maakt voor haar werk dus niet uit. In de vakjes bij woensdagochtend en woensdagmiddag schrijven we **vrij**.
- Donderdagochtend heeft mevrouw De Groot vrij genomen van haar werk. In het vakje bij donderdagmiddag schrijven we **vrij**.
- Donderdagmiddag is mevrouw De Groot wel weer gaan werken. De hele vrijdag heeft ze ook gewerkt. Dus in die drie vakjes schrijven we **gewerkt**.
- Zaterdag en zondag heeft mevrouw De Groot niet gewerkt, omdat ze dan altijd vrij is. Dus in die vakjes schrijven we **vrij**.

Voor mevrouw De Groot ziet het schema van vorige week er zo uit:

**Vorige week – mevrouw De Groot (Voorbeeld)**

| Vorige week    | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| <i>ochtend</i> | gewerkt | ziek    | vrij     | vrij      | gewerkt | vrij     | vrij   |
| <i>middag</i>  | ziek    | ziek    | vrij     | gewerkt   | gewerkt | vrij     | vrij   |

Vul nu voor uzelf de schema's hieronder in. Deze zijn voor de afgelopen 4 weken.  
Let op: pak uw agenda erbij! En begin bij vorige week. Vul in ieder vakje van deze week een van deze drie woorden in: **gewerkt**, **vrij** of **ziek**.

| Vorige week    | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| <i>ochtend</i> |         |         |          |           |         |          |        |
| <i>middag</i>  |         |         |          |           |         |          |        |

Het schema hieronder is voor de week vóór week 1. Dat is 2 weken geleden. Pak weer uw agenda. En vul weer in ieder vakje een van deze drie woorden in: **gewerkt**, **vrij** of **ziek**.

| 2 weken geleden | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| <i>ochtend</i>  |         |         |          |           |         |          |        |
| <i>middag</i>   |         |         |          |           |         |          |        |

Het schema hieronder is voor de week vóór week 2. Dat is 3 weken geleden. Pak weer uw agenda. En vul weer in ieder vakje een van deze drie woorden in: **gewerkt**, **vrij** of **ziek**.

| 3 weken geleden | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| <i>ochtend</i>  |         |         |          |           |         |          |        |
| <i>middag</i>   |         |         |          |           |         |          |        |

Het schema hieronder is voor de week vóór week 3. Dat is 4 weken geleden. Pak weer uw agenda. En vul weer in ieder vakje een van deze drie woorden in: **gewerkt**, **vrij** of **ziek**.

| 4 weken geleden | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|
| <i>ochtend</i>  |         |         |          |           |         |          |        |
| <i>middag</i>   |         |         |          |           |         |          |        |

Heeft u alle vakjes ingevuld? Dan heeft u de vraag goed beantwoord.

Zijn er nog vakjes leeg? Kijk dan nog een keer goed in uw agenda en probeer bij iedere ochtend of middag te bedenken of u toen gewerkt heeft, vrij was of ziek was. Vul zo alle vakjes in die nog leeg zijn.

